فصل سوم:بیماری‌های پالپ و پری اپیکال

۱- در مورد pulpitis همگی صحیح است به جز:

الف) درد پالپی هرگز از midline نمی‌گذرد.

ب) اگر درد به هنگام جویدن ایجاد شود اغلب یک cracked tooth وجود دارد.

ج) بررسی هیستوپاتولوژی پالپیت تاثیر مهمی در درمان ندارد.

د) در پالپیت برگشت‌پذیر احتقان وریدها (congestion) دیده می‌شود.

۲- در مورد پالپیت غیرقابل برگشت همگی صحیح است به جز:

الف) به طور معمول پرخونی (hyperemia) دیده می‌شود که منجر به نکروز موضعی می‌گردد.

ب) منطقه نکروتیک حاوی لکوسیت‌های پلی مورفونوکلئر و هیستیوسیت‌ها می‌باشد.

ج) بافت پالپ احاطه‌کننده نکروز و فیبروز نشان می‌دهد.

د) مخلوطی از پلاسماسل‌ها، لنفوسیت‌ها و هیستوسیت‌ها دیده می‌شود.

۳- در مورد میکروسکوپی pulp polyp همگی صحیح است به جز:

الف) کلسیفیکاسیون پالپی در قسمت ریشه‌ای و تاجی ناشایع‌اند.

ب) ناحیه اپیکال بافت پالپ معمولاً طبیعی است و حداقل التهاب و فیبروز را نشان می‌دهد.

ج) از نظر هیستوپاتولوژی مشابه پیوژنیک گرانولوما است.

د) ممکن است سطح پالپیت با اپی تلیوم مطبق سنگفرشی مفروش شود.

۴- همگی با افزایش ساخت secondary dentin مرتبط‌اند به جز:

الف) arthritis ب) gout ج) افزایش فشار خون د) myasthenia gravis

۵- همگی در ساخت عاج کانونی دخیل‌اند به جز:

الف) بیماری پریودنتال ب) تحریک ناشی از مواد دندانی

ج) fracture د) پری کورونیت

Scanned with CamScanner

۶- کلسیفیکاسیون‌های پالپی در تمام موارد افزایش می یابد به جز:

الف) هایپرویتامینوز C
ب) Dentin dysplasia II
ج) مکمل‌های فلوراید
د) افزایش سن

۷- همگی همراه با افزایش کلسیفیکاسیون‌های پالپی بارز می‌باشند به جز:

الف) مراحل انتهایی بیماری کلیوی
ب) Ehlers – Danlos syn
ج) pulpal dysplasia
د) tuberous sclerosis

۸- کدام سلول‌ها در apical periodontitis موجب فراخوانی استئوکلاست‌ها می‌شوند؟

الف) ائوزینوفیل
ب) نوتروفیل
ج) لنفوسیت
د) پلاسماسل

۹- در periapical granuloma کدام سلول‌های التهابی شیوع پایین‌تری دارند؟

الف) نوتروفیل
ب) پلاسماسل
ج) هیستیوسیت
د) mast cell

۱۰-کدام‌یک از موارد زیر ممکن است بعد از درمان مناسب عفونت موجب شکست درمان شود؟

الف) pulse granuloma
ب) cholesterol cleft
ج) Rushton bodies
د) Rest of malassez

۱۱-تمام موارد در گرانولوم پری اپیکال می‌تواند دیده شود به جز:

الف) ژانت سل
ب) cholesterol clefts
ج) Rushton bodies
د) pulse granuloma

۱۲- تمام موارد زیر فرد را مستعد cellulitis می‌کند به جز:

الف) دیابت ملیتوس
ب) آنمی آپلاستیک
ج) malignancy
د) افزایش فشار خون

۱۳- در مورد پالپیت برگشت پذیر همه مطالب صادق است به جزء :

الف) درد بدون تحریک ایجاد نمی‌شود
ب) لقی و حساسیت به دق وجود ندارد
ج) دندان به تست الکتریکی با جریان بالاتری پاسخ می‌دهد
د) دندان به تحریکات سرما پاسخ شدید می‌دهد

Scanned with CamScanner

۱۴- در مورد پالپیت برگشت ناپذیر کدام دیده نمی‌شود؟

الف) درد خودبه خود و مداوم

ب) گرما شدت درد را افزایش می‌دهد ا ما سرما تسکین دهنده است

ج) لقی و حساسیت به دق وجود دارد

د) درد هنگام دراز کشیدن تشدید می‌شود

۱۵- pulp polyp در کدام دندان شایع‌تر است؟

الف) مولر دائمی ب) سانترال‌های بالا ج) پره مولر پایین د) کانین

۱۶- Calcific metamorphosis به چه معنا است؟

الف) آسیب تروماتیک و انسداد زودرس اتاقک پالپ و کانال

ب) تشکیل عاج ثانویه در Progeria

ج) تشکیل عاج ثالثیه reactionary

د) تشکیل عاج ثالثیه reparative

۱۷- رسوب عاج ثانویه در کدام نواحی حداکثر و حداقل است؟ (به ترتیب)

الف) کف پالپ- دیواره‌ها- سقف پالپ ب) سقف پالپ- دیواره‌ها- کف پالپ

ج) کف پالپ- سقف پالپ- دیواره‌ها د) سقف پالپ- کف پالپ – دیواره‌ها

۱۸- عاج ثالثیه Reactionary به چه معنا است؟

الف) عاج ثانویه‌ای که در پاسخ به آسیب موضعی شدید ایجاد می‌شود

ب) عاج ثانویه‌ای که در پاسخ به آسیب موضعی خفیف تا متوسط ساخته می‌شود

ج) عاج ثانویه‌ای فیزیولوژیک که با افزایش سن ارتباط دارد.

د) عاج ثانویه‌ای که توسط ادنتوبلاست‌های تازه تشکیل شده ایجاد می‌شود

۱۹- Fibro dentin به چه معنا است؟

الف) همان Interface dentin است ب) لایه اولیه دنتین Reparative است

ج) بدون سلول یا دارای هسته پراکنده است د) تمام موارد صحیح می‌باشد

۲۰- درگیری کدام فضا در آنژین لودویک دیده نمی‌شود؟

الف) زیرزبانی ب) تحت فکی ج) فضای باکال د) زیر چانه‌ای

Scanned with CamScanner

۲۱- علامت bull neck در کدام بیماری و چرا ایجاد می‌شود؟

الف) آنژین لودویک – گسترش به فضای تحت فکی

ب) آنژین لودویک- گسترش به فضای زیرزبانی

ج) ترومبوز سینوس کاورنوس- گسترش به فضای زیرزبانی

د) ترومبوز سینوس کاورنوس- گسترش به فضای تحت فکی

۲۲- آنژین لودویک بیشتر به علت عفونت کدام دندان ایجاد می‌شود؟

الف) کانین پایین ب) مولر پایین ج) پره مولر پایین د) سانترال‌های پایین

۲۳- همگی جزء عوامل مستعد کننده استئومیلیت Suppurative اند به جزء :

الف) ضعف ایمنی ب) استئوپتروز ج) مالاریا د) ترومبوسیتوپنی

۲۴- از نظر رادیوگرافی Diffuse sclerosing osteomylitis با کدام قابل اشتباه است؟

الف) بیماری پاژت ب) فلورید سمنتو اسئوس دیسپلازی

ج) بیماری Gorham د) موارد الف و ب

۲۵- در مورد Diffuse sclerosing osteomyelitis کدام صادق نیست؟

الف) یک بیماری عفونی به طور مستقیم مسئول ایجاد اسکلروزیس استخوان است

ب) تشکیل استخوان جدید پریوستئال دیده می‌شود

ج) در پریودنتیت و پری کورنیت ایجاد می‌شود

د) کشت میکروبی منفی است

۲۶- در کدامیک کشت میکروبی مثبت می‌شود؟

الف) SAPHO syn

ب) Chronic recurrent multifocal osteomyelitis

ج) Diffuse Sclerosing osteomyelitis

د) Chronic tendo periostitis

۲۷- کدام ضایعات مشابه Primary chronic osteomyelitis می‌باشند اما تظاهرات خارج فکی نیز دارند؟

الف) SAPHO syn

ب) Chronic recurrent multifocal osteomyelitis

ج) Diffuse sclerosing osteomyelititis

د) موارد الف و ب

Scanned with CamScanner

۲۸-علائم کلاسیک chronic tendoperiostitis تمام موارد زیر است به جزء :

الف) تریسموس ب) درد راجعه ج) تورم گونه د) خروج چرک

۲۹-در مورد Condensing osteitis همگی صحیح است به جزء :

الف) همیشه در ارتباط با آپکس یک دندان غیر زنده است

ب) اتساع کلینیکی دیده نمی‌شود

ج) در نواحی پره مولر و مولر ماندیبل شایع‌تر است

د) در افراد میانسال دیده می‌شود

۳۰- کدام کلسیفیکاسیون پالپی رادیوگرافی ندارد؟

الف) Denticle ب) pulp stone

ج) Diffuse linear calcification د) موارد الف و ب

۳۱- کلسیفیکاسیون پالپ در کدام دیده نمی‌شود؟

الف) Ehlers- Danlos syn ب) pulpal dysplasia

ج) Dentin dysplasia Id د) سندرم مارفان

۳۲-منشأ کیست پری اپیکال تمام موارد زیر می‌تواند باشد به جزء :

الف) بقایای مالاسز ب) بقایای Dental lamina

ج) اپی تلیوم شیار لثه د) پوشش سینوس

۳۳- کلسیفیکاسیون دیستروفیک در رادیوگرافی کدام دیده می‌شود؟

الف) residual cyst ب) Radicular cyst

ج) odontogenic Keratocyst د) Dentigerous cyst

۳۴-حوضچه‌های کوچکی از مواد ائوزینوفیلیک با حاشیه چین خورده از کلاژن متراکم چه نامیده می‌شود؟

الف) Rushton body ب) Russell body

ج) Pulse granuloma د) pyronin body

۳۵- کدام جزء نمای رادیوگرافیک رادیکولار کیست نیست؟

الف) Root resorption ب) از بین رفتن لامینادورا

ج) رادیوگرافی با حدود نامشخص د) رادیولوسنسی مولتی لاکولار

Scanned with CamScanner

۳۶- در تمام موارد زیر جراحی اندیکاسیون دارد به جزء :

الف) residual cyst
ب) Radicular cyst
ج) Lateral radicular cyst
د) Fibrous periapical scar

۳۷- کدام جمله در مورد periapical cyst صحیح است؟

الف) در pocket cyst به علت عدم گسترش آپکس به داخل کیست اپی تلیوم کامل است
ب) در true cyst به علت حضور انتهای ریشه در داخل کیست، اپی تلیوم ناقص است
ج) نمای رادیوگرافی آن مشابه گرانولوم پری اپیکال است
د) در پوشش کیست ممکن است سلول‌های موکوسی دیده شود اما سلول استوانه‌ای مژکدار دیده نمی‌شود

۳۸- در مورد periapical abscess کدام صحیح نیست؟

الف) در رادیوگرافی ضخیم شدن PDL در ناحیه اپکس دیده می‌شود
ب) در آبسه فونیکس تخریب استخوان دیده می‌شود
ج) مدخل sinus tract پارولیس نامیده می‌شود
د) در لترال ماگزیلا و مولر دوم و سوم ماندیبل، سمت باکال پرفوره می‌شود

۳۹-woody tongue از علائم کدام ضایعه است؟

الف) آنژین لودویک
ب) ترومبوز سینوس کاورنوس
ج) آبسه فونیکس
د) آبسه حاد پری اپیکال

۴۰- همگی موجب ساخت استخوان پریوستئال می‌شوند به جز:

الف) Langerhans cell histiocytosis
ب) Ewing sarcoma
ج) osteosarcoma
د) simple bone cyst

۴۱- در مورد میکروسکوپی Proliferative periostitis همگی صحیح است به جز:

الف) ردیف‌های موازی از استخوان woven و بسیار پرسلول دیده می‌شود.
ب) ترابکول‌های منفرد نسبت به سطح عمودی قرار می‌گیرند.
ج) ممکن است نمایی شبیه دیسپلازی فیبرو نابالغ ایجاد کند.
د) بین ترابکول‌های سلولار بافت همبندی فیبروزه التهابی دیده می‌شود.

Scanned with CamScanner

۴۲-همگی تورم ایجاد می‌کنند به جز:

الف) استئومیلیت گاره
ب) condensing osteitis
ج) fibrous dysplasia
د) ossifying fibroma

۴۳-در مورد نمای رادیوگرافی Focal cemento- osseous وfocal sclerosing osteomyelitis dysplasiaکدام صحیح است؟

الف) در مورد اول رادیواپسیتی از آپکس جداست اما در مورد دوم خیر
ب) در مورد اول رادیواپسیتی از آپکس جدا است اما در مورد دوم ضایعه فاقد حاشیه رادیولوسنت است
ج) هر دو ضایعه فاقد حاشیه رادیولوسنت می‌باشند
د) در مورد اول رادیواپسیتی به‌آپکس چسبیده است و ضایعه دوم دارای حاشیه رادیولوسنت می‌باشد

۴۴- در مورد condensing osteitis و Idiopathic osteosclerosisکدام صادق است؟

الف) هر دو اتساع کلینیکی می‌دهد
ب) هر دو دارای حاشیه رادیولوسنت در نمای رادیوگرافی می‌باشند
ج) در مورد اول حتماً اتصال به آپکس دیده می‌شود
د) در هر دو دندان غیر زنده باید وجود داشته باشد

۴۵- شایع‌ترین علت ایجاد proliferative periostitis کدام است؟

الف) تروما
ب) پوسیدگی
ج) عفونت پریودنتال
د) استئومیلیت

۴۶- دلایل شایع تشکیل استخوان پریوستئال شامل تمام موارد زیر است به جزء :

الف) langerhance cell histiocytosis
ب) congenital syphilis
ج) infantile cortical hyperostosis
د) central giant cell granuloma

۴۷- کدامیک از انواع کلسیفیکاسیون‌های پالپی زیر در نتیجه عمل متقابل اپی‌تلیوم و مزانشیم به وجود می‌آید؟

الف) دنتیکل
ب) سنگ‌های پالپی
ج) کلسیفیکاسیون خطی منتشر دور عصب
د) کلسیفیکاسیون منتشر دور عروق

Scanned with CamScanner

۴۸- تفاوت گرانولوم نوک ریشه و کیست رادیکولر در کدام است؟

الف) تصویر میکروسکوپی ب) نمای رادیوگرافیک ج) علائم کلینیکی د) اندازه ضایعه

۴۹- تمام موارد زیر در گرانولوم پری اپیکال دیده می‌شود به جز :

الف) اجسام Russell ب) اجسام pyronine

ج) بقایای مالاسز د) اجسام Rushton

۵۰- کدامیک در مورد Bone scar صحت دارد؟

الف) ناحیه رادیولوسنت باقی مانده و ترمیم شده توسط نسج اسکارپس از کشیدن دندان است

ب) ناحیه باقی مانده رادیواوپاک استئیت کندانسه پس از حذف کانون آماس است

ج) رادیولوسنسی کاملاً محدود پس از حذف کانون آماسی در استئیت کندانسه است

د) همان استئیت کندانسه است که در آپکس ریشه دندان غیر عفونی دیده می‌شود

۵۱-کدام مورد زیر از نظر میکروسکوپی ممکن است شبیه دیسپلازی فیبرو نابالغ شود؟

الف) condensing osteitis

ب) Sternocostoclavicular hyperostosis

ج) acute suppurative osteomyelitis

د) chronic suppurative osteomyelitis

Scanned with CamScanner